

Fobia *afektu*

Pacjent uczy się w dzieciństwie, że pewne uczucia są „niedozwolone” — i zaczyna się ich bać jak fobii. Leczenie jest analogiczne do ekspozycji: stopniowa desensytyzacja afektu.

CZAS: 30 min · poziom zaawansowany Pacjent odcięty od emocji; somatyzacja; klaster C

ŹRÓDŁO: McCullough (1997, 2003)

JAK UŻYWAĆ

Pracujesz z modelem łączącym terapię psychodynamiczną z teorią uczenia się (terapia fobii afektu, ang. *Affect Phobia Therapy*). Identyfikujesz dominującą fobię afektywną i prowadzisz desensytyzację w czterech ruchach: **restrukturyzacja obron** (pokazujesz, jak pacjent unika uczucia), **ekspozycja afektu** (zachęcasz do odczucia go w bezpiecznym kontekście), **restrukturyzacja siebie** (nowa relacja z własnym uczuciem) i **restrukturyzacja innych** (nowa relacja ze światem).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Jeśli pewne emocje powodowały kiedyś odrzucenie, karę lub utratę więzi, stają się bodźcem lękorodnym — pacjent unika ich przez obrony, a afekty pozostają niedostępne. Skoro to nauczony lęk, można go **oddzielić jak fobię**: przez stopniową ekspozycję pacjent odkrywa, że uczucie go nie zniszczy ani nie pozbawi relacji. Badanie z randomizacją wykazało dużą skuteczność tego modelu w zaburzeniach osobowości z klastra C (McCullough i in., 2003).

01 Sześć typowych fobii afektywnych

Złość — „złość zniszczy relację”

Tęsknota / bliskość — „potrzebować = być słabym”

Wstyd / bezradność — „nie wolno mi czuć słabości”

Żal / żałoba — „jeśli poczuję, rozpadnę się”

Radość / duma — „jak się cieszę, spadnie nieszczęście”

Pożądanie — „to niebezpieczne lub złe”

02 Zidentyfikuj dominującą fobię

Której emocji pacjent najbardziej unika? Wprowadź psychoedukację: „afekt to nie choroba — to informacja. Fobia afektu to nauczone unikanie, można je oduczyć.”

DOMINUJĄCA FOBIA AFEKTYWNA TEGO PACJENTA

03 Pięć kroków desensytyzacji

- ① **Restrukturyzacja obron** — pokaż, jak pacjent unika afektu; nazwij koszt
- ② **Ekspozycja afektu** — „co Pani teraz czuje w ciele? Co by się pojawiło, gdyby Pani sobie pozwoliła?”
- ③ **Graduacja** — od mniej intensywnych wersji uczucia po silniejsze
- ④ **Restrukturyzacja siebie** — „jaka Pani staje się z tym uczuciem?”
- ⑤ **Restrukturyzacja innych** — „jak mogą wyglądać relacje, gdy to uczucie będzie dostępne?”

04 Plan ekspozycji dla tego pacjenta

Zapisz, od jakiej łagodnej wersji afektu zaczniesz i jak będziesz stopniować intensywność.

PUNKT WYJŚCIA I GRADUACJA

Klucz: u pacjentów depresyjnych najczęstszą fobią są złość i żal — pacjent nie pozwala sobie na złość („byłabym jak matka”), a depresja ją zastępuje. Odblokowanie złości często znacząco łagodzi depresję. Ale nie „wywołuj” emocji mechanicznie — pozwól jej pojawić się w bezpiecznym kontekście, gdy obrony się rozluźniają.